SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

GOVERNO DO PARÁ

DIRETORIA DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR

CARTILHA



Orientações básicas
“Saiba o que fazer”

Caro servidor,

Com esta cartilha, temos um único objetivo:
orientar você a como agir, com prudência, em situações que podem exigir uma ação imediata de primeiros socorros, seja no trabalho, em casa ou em qualquer outro lugar.

Em apenas 15 minutos de leitura, você acessará noções básicas de atendimento que podem vir a ser determinantes quando adversidades colocam vidas humanas em risco.

Faça bom proveito!

Diretoria de Saúde Ocupacional do Servidor
Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
Coordenadoria de Perícia Médica
Conteúdo: Coordenadoria de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho
Projeto Gráfico: Núcleo de Comunicação da SEPLAD

SUMÁRIO

O que são Primeiros Socorros	**4**
Queimaduras	**5**
Asfixia	**6**
Parada Cardiorrespiratória (PCR)	**7**
Desmaio	**7**
Convulsão	**8**
Hipoglicemia	**8**
Números Importantes	**10**
Referências	**10**

O que são Primeiros Socorros
- São cuidados prestados, com brevidade, a pessoas (vítimas) em situações de acidentes ou mal súbito, no local onde o fato está ocorrendo, visando à manutenção da vida.

Socorrista
- É a pessoa capacitada que tem como principal finalidade avaliar e identificar com segurança problemas que comprometam a vida, mantendo as funções vitais da pessoa, evitando o agravamento das lesões ou dos sintomas.

Qualidades desejadas no socorrista
- Autocontrole e sentido de responsabilidade;
- Capacidade de organização e liderança;
- Capacidade de comunicação;
- Capacidade para tomar decisões rápidas;
- Compreensão e respeito pelo outro;
- Consciência das suas limitações.

Etapas básicas para a prestação de Primeiros Socorros

Avaliação do local do acidente:
- Observar rapidamente se existem perigos para quem vai prestar o socorro ou para o acidentado e pessoas nas proximidades da ocorrência;
- Observar a existência de fios elétricos soltos e desencapados, tráfego de veículos, andaimes, vazamento de gás, máquinas funcionando;
- Evitar o pânico e identificar pessoas que possam ajudar procurando dar ordens breves, claras, objetivas e concisas.

Avaliação da vítima:
- Observar os sinais vitais (respiração e pulso prioritariamente, temperatura e pressão arterial);
- Verificar o estado de consciência: avaliando se consegue responder a perguntas simples
com respostas lógicas como nome, idade, se sente dor ou desconforto, onde, etc., sem, entretanto, movimentá-la;
- Caso não responda, verificar se está respirando, observando movimentos torácicos e abdominais com entrada e saída de ar normalmente pelas narinas ou boca, ou ainda escutando-o, sempre com cuidado para não desalinhar a coluna cervical;
- Avaliar se há queimaduras, fraturas ou objetos encravados;
- Aplicar calmamente os procedimentos de Primeiros Socorros ao acidentado;
- Ter discernimento quanto aos limites do que pode ser comunicado ao acidentado daquilo que está sendo visualizado nele ou em outros acompanhantes também acidentados;
- Impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente, evitando assim causar o chamado “segundo trauma”, isto é, não ocasionar outras lesões ou agravar as já existentes, até a chegada do atendimento médico emergencial.



Algumas dicas de Primeiros Socorros

1. **Queimadura:** É qualquer ferimento provocado pela ação do calor, frio, eletricidade ou substância química sobre o organismo.

São classificadas em:

Queimaduras de 1º grau – vermelhidão (lesões de camadas superficiais da pele);
Queimaduras de 2º grau – vermelhidão e bolhas (lesões de camadas mais profundas da pele);
Queimaduras de 3º grau – destruição de tecidos que podem estar escuros ou esbranquiçados (lesões de todas as camadas da pele, comprometimento dos tecidos mais profundos, órgãos e nervos).

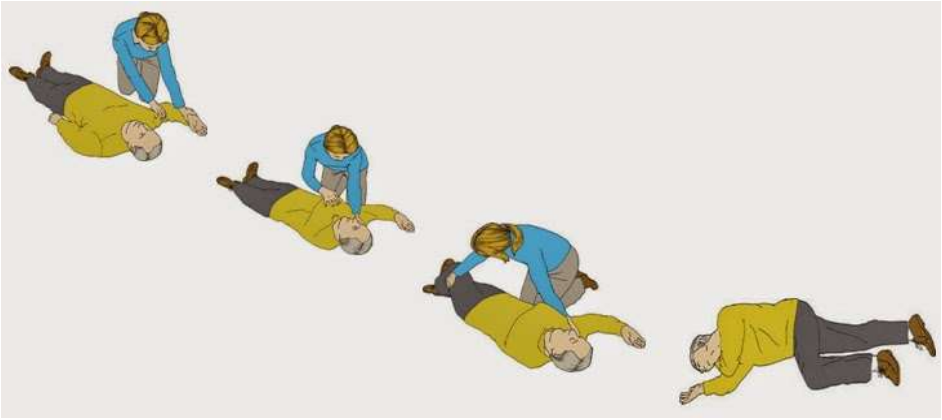
Procedimentos
- Retire a roupa e objetos como correntes e relógio que não estiverem grudados; caso estejam grudados, não retire, pois pode ocasionar lesões graves;
- Se a queimadura for por substância sólida, retire o excesso com pano seco (sempre procurando proteger-se), lavando em água corrente e limpa, abundantemente e sem fazer pressão, pois alivia a dor e retira o excesso de substâncias químicas;
- Proteja com pano limpo e molhado em água limpa;
- Não utilize nenhum tipo de pomada ou produtos caseiros na área afetada pela queimadura, somente água e também não fure as bolhas que se formarem ou já existam;
- Chame o socorro especializado, encaminhando, junto com a vítima, a embalagem ou rótulo do produto que causou a lesão para ser identificado.
- Manter o repouso e compressões com gelo no local.
- Evitar o banho e administração de alimentos quentes.



2. **Asfixia**: É uma parada respiratória com o coração ainda funcionando. É causada por certos tipos de traumatismos como aqueles que atingem a cabeça, a boca, o pescoço, o tórax; por fumaça no decurso de um incêndio; por afogamento; em soterramentos, dentre outros acidentes, ocasionando dificuldade respiratória, levando à parada respiratória. Se as funções respiratórias não forem restabelecidas dentro de 3 a 4 minutos, as atividades cerebrais cessarão totalmente, ocasionando a morte.

Procedimentos

- Favorecer a passagem do ar através da boca e das narinas;
- Verificar se o acidentado está consciente;
- Desapertar as roupas, principalmente em volta do pescoço, peito e cintura;
- Retirar qualquer objeto da boca ou da garganta do acidentado, para abrir e manter desobstruída a passagem de ar;
- Para assegurar que a pessoa inconsciente continue respirando, coloque-a na posição lateral de segurança (imagem abaixo);



- Iniciar a respiração de socorro (caso tenha treinamento para isso), tão logo tenha sido o acidentado colocado na posição correta;

- Repetir a respiração de socorro tantas vezes quanto necessário, até que o acidentado dê entrada em local onde possa receber assistência adequada;
- Manter o acidentado aquecido, para prevenir o choque;
- Não dar líquidos enquanto o acidentado estiver inconsciente;
- Não deixar o acidentado sentar ou levantar. Ele deve permanecer deitado, mesmo depois de ter recuperado a respiração;
- Não dar bebidas alcoólicas. Dar chá ou café para beber, logo que volte a si;
- Continuar observando cuidadosamente o acidentado, para evitar que a respiração cesse novamente;
- Não deslocar a pessoa até que sua respiração volte ao normal;
- Remover o acidentado, somente deitado, mas só em caso de extrema necessidade;
- Em qualquer das situações, solicitar sempre o socorro especializado, mesmo que o acidentado esteja recuperado.

3. **Parada Cardiorrespiratória (PCR)**: É a interrupção repentina da função de bombeamento cardíaco, que pode ser constatada pela falta de batimentos (ao encostar o ouvido na região anterior do tórax do acidentado), pulso ausente (não se consegue palpar o pulso) e ainda quando houver dilatação das pupilas (menina dos olhos), e que, pode ser revertida com intervenção rápida, mas que causa morte se não for tratada.

Procedimentos
- Observar elementos como imobilidade e palidez;
- Checar o nível de consciência, tentando observar as respostas do acidentado aos estímulos verbais: "Você está bem?".
- Posicionar a pessoa em decúbito dorsal, sobre superfície plana e rígida;
- Observar ausência de pulso numa grande artéria (por exemplo: carótida); apneia ou respiração arquejante; espasmo (contração súbita e violenta) da laringe; cianose (coloração arroxeada da pele e lábios); inconsciência; dilatação das pupilas;
- Comunicar imediatamente ao atendimento especializado.

OBS: A Ressuscitação Cardiorrespiratória (RCR) reúne manobras capazes de reverter o quadro de PCR, desde que realizadas a tempo e por socorristas habilitados. Portanto, é fundamental solicitar apoio ao atendimento especializado com desfibrilação e recursos de suporte avançado.

4. **Desmaio**: é a perda súbita, temporária e repentina da consciência, devido à diminuição de sangue e oxigênio no cérebro. Pode ser causado por hipoglicemia; cansaço excessivo; fome; nervosismo intenso; emoções súbitas; susto; acidentes, principalmente os que envolvem perda sanguínea; dor intensa; prolongada permanência em pé; mudança súbita de posição (de deitado para em pé); ambientes fechados e quentes; disritmias cardíacas (bradicardia).

Procedimentos
- Se a pessoa apenas começou a desfalecer, sentá-la em uma cadeira, ou outro local semelhante, e curvá-la para frente;
- Baixar a cabeça do acidentado, colocando-a entre as pernas e pressionar a cabeça para baixo;
- Manter a cabeça mais baixa que os joelhos;
- Fazer a pessoa respirar profundamente, até que passe o mal-estar.
- Havendo o desmaio, manter o indivíduo deitado, colocando sua cabeça e ombros em posição mais baixa em relação ao resto do corpo;
- Afrouxar a roupa e manter o ambiente arejado;
- Se houver vômito, lateralizar a cabeça, para evitar sufocamento;
- Depois que o acidentado se recuperar, pode ser dado a ele café, chá ou mesmo água com açúcar. Não se deve dar jamais bebida alcoólica.

5. **Convulsão**: é uma contração violenta, ou série de contrações dos músculos voluntários, com ou sem perda de consciência.

Procedimentos
- Tentar evitar que a vítima caia desamparadamente, cuidando para que a cabeça não sofra traumatismo e procurando deitá-la no chão com cuidado, acomodando-a;
- Retirar da boca próteses dentárias móveis (pontes, dentaduras) e eventuais detritos;
- Remover qualquer objeto com que a vítima possa se machucar e afastá-la de locais e ambientes potencialmente perigosos, como por exemplo: escadas, portas de vidro, janelas, fogo, eletricidade, máquinas em funcionamento;
- Não interferir nos movimentos convulsivos, mas assegurar-se que a pessoa não está se machucando;
- Afrouxar as roupas no pescoço e na cintura;
- Virar o rosto da vítima para o lado, evitando assim a asfixia por vômitos ou secreções;
- Não colocar nenhum objeto rígido entre os dentes da vítima;
- Tentar introduzir um pano ou lenço enrolado entre os dentes para evitar mordedura da língua;
- Não jogar água fria no rosto da pessoa;
- Quando passar a convulsão, manter a vítima deitada até que ela tenha plena consciência e autocontrole;
- Se a pessoa demonstrar vontade de dormir, deve-se ajudar a tornar isso possível, de preferência na posição lateral de segurança;
- Contatar o atendimento especializado.

6. **Hipoglicemia:** A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que promove a entrada da glicose nas células. Quando há muita insulina no sangue, muita glicose entra nas células e pouca permanece na corrente sanguínea, o que caracteriza a hipoglicemia. Geralmente, define-se a hipoglicemia quando a quantidade de açúcar no sangue vai para baixo de 70mg/dL. Existem dois tipos principais de hipoglicemia: a hipoglicemia de jejum e a pós-prandial (ou reativa), que ocorre depois das refeições.

Entre as causas da hipoglicemia de jejum destacam-se:

- Produção excessiva de insulina pelo pâncreas;
- Uso incorreto de medicamentos utilizados no tratamento de diabetes (por exemplo, ao tomar doses maiores que as indicadas);
- Insuficiência hepática, cardíaca ou renal;
- Tumores pancreáticos;
- Consumo de álcool;
- Excesso de atividade física sem compensação na alimentação;
- Deficiência dos hormônios que ajudam a liberar glicogênio.

A hipoglicemia pós-prandial ou reativa ocorre por volta de 3 a 5 horas depois das refeições, como resultado do desequilíbrio entre os níveis de glicose e de insulina no sangue. Em geral, ela se manifesta em pessoas predispostas depois da ingestão de alimentos ricos em açúcar, nos pacientes submetidos à cirurgia do estômago e naqueles em fase inicial da resistência à insulina.

Sintomas:

- Tremores;
- Tonturas;
- Palidez;
- Suor frio;
- Palpitações;
- Taquicardia;
- Dor de cabeça;
- Náuseas;
- Vômitos;
- Sonolência;
- Fome;
- Confusão mental;
- Alterações do nível de consciência;
- Perturbações visuais e de comportamento que podem ser confundidas com embriaguez, cansaço, fraqueza, sensação de desmaio e convulsões.

Procedimento

Uma vez instalada a crise hipoglicêmica, o paciente deve consumir de 15 g a 20 g de carboidratos simples. Essa medida equivale, por exemplo, a:

- Uma colher de sopa de mel (exceto em casos de crianças menores de 1 ano);
- Um copo de 200 mL de suco de laranja ou de refrigerante não dietético;
- Uma colher de sopa de açúcar dissolvido em meio copo de água.

O efeito será mais rápido se esses alimentos forem ingeridos junto com carboidratos de longa duração, como pães, pipocas, biscoitos etc.

No caso de quem tem diabetes, é recomendado medir a glicemia 15 minutos após a ingestão e, se ela continuar baixa, consumir mais uma porção de algum desses alimentos.

Se o nível de consciência estiver comprometido, o paciente deve ser encaminhado para atendimento médico a fim de receber a medicação adequada.

Números importantes:
SAMU – 192
BOMBEIROS – 193
DEFESA CIVIL – 199

REFERÊNCIAS

Biblioteca Nacional de Portugal – Catalogação da Publicação REIS, Isabel, 1952 - Manual de primeiros socorros: situações de urgência nas escolas, jardins de infância e campos de férias ISBN 978-972-742-330-9 CDU 614

Mª Almeida de, Práticas de Enfermagem: ensinando a cuidar de clientes em situações clínicas e cirúrgicas – São Caetano do Sul/SP: Difusão Editora, 2002. Apostila de "Noções de primeiros socorros" – Colégio Fênix, 2002.

ARCHER, E. Procedimentos e Protocolos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de condutas médicas. Manual de condutas médicas. São Paulo, 2001.

BRASIL, Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual Em Saúde. 2017.

CARVALHO, M. G. Atendimento Pré Hospitalar para Enfermagem: Suporte básico e avançado de vida. São Paulo: Látria, 2004.

GUIA ILUSTRADO DE PRIMEIROS SOCORROS. Circulo do Livro: 1996. KAWAMOTO, E. E.

Acidentes: como socorrer e prevenir. São Paulo: E.P.U., 2002.

MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 170 p.

MURTA, G. F. Saberes e práticas: Guia para ensino e aprendizado de enfermagem. São Paulo:

Difusão, 2008.

OLIVEIRA, M. Fundamentos do socorro pré-hospitalar: manual de suporte básico de vida para socorristas. Florianópolis, 2004.

PUGIRÁ, M. S. ET. AL. Plantão Médico: Meio ambiente, Estresse, Sedentarismo, Nutrição

(diabetes) e Ergonomia. Biologia e Saúde, 2003.

SANTA CATARINA, Secretaria do Estado da Saúde/DIVE. Acidentes com animais peçonhentos e condutas.

SMELTZER, S.C. & BARE B.G Brunner & Suddart: Tratado de enfermagem médica cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.